

La neuromodulation sacrée (SNM) est un petit dispositif implanté — parfois appelé « stimulateur vésical » — qui stimule doucement les **nerfs sacrés** près du coccyx, lesquels contrôlent la vessie et l'intestin. Elle est utilisée en cas de vessie hyperactive, de certaines rétentions urinaires et de fuites intestinales involontaires lorsque les autres traitements ont échoué. Son atout majeur : vous **la testez d'abord** avant de vous engager.

Comment ça fonctionne

Les nerfs sacrés transmettent les signaux entre la vessie/l'intestin et le cerveau. La SNM délivre de **légères impulsions électriques** qui normalisent ces signaux — réduisant les urgences et les fuites, ou aidant une vessie qui ne se vide pas. Vous la contrôlez avec une télécommande.

Ce qu'elle traite

- **Vessie hyperactive** (urgenterie, pollakiurie, fuites par urgenterie) résistante aux autres traitements
- **Rétention urinaire non obstructive** (vessie qui ne se vide pas)
- **Fuites intestinales involontaires** (incontinence fécale)

COMPRENDRE LES TERMES

Nerfs sacrés

Nerfs proches du coccyx qui contrôlent la vessie et l'intestin.

Neuromodulation

Utilisation de légères impulsions électriques pour stabiliser les signaux nerveux.

Phase de test

Essai avec une électrode temporaire pour évaluer l'efficacité avant l'implant définitif.

Boîtier (générateur)

Petit dispositif à pile implanté sous la peau de la fesse supérieure.

Électrode

Fin fil qui transmet la stimulation au nerf.

Télécommande

Appareil portatif pour régler ou mettre en pause le dispositif.

COMMENT SAVOIR SI ÇA VA MARCHER POUR MOI ? C'est tout l'avantage — vous **essayez avant de vous engager**. Un fin fil temporaire est mis en place et vous suivez vos symptômes pendant environ 1–2 semaines. Ce n'est que si l'amélioration est nette (environ 50 % ou plus) que vous passez au petit implant définitif.

Comment ça se déroule (deux étapes)

- 1 Phase de test :** une électrode fine est placée près d'un nerf sacré (intervention mineure) ; vous tenez un journal pendant 1–2 semaines pour mesurer l'amélioration.
- 2 Implant :** si le test est concluant, un petit **boîtier** est placé sous la peau de la fesse supérieure et relié à l'électrode — en ambulateur.
- 3** Vous utilisez une **télécommande** pour ajuster les réglages programmés par votre équipe.

Après

- Légère sensibilité au site pendant quelques jours ; évitez les activités intenses brièvement.
- La pile dure plusieurs années (rechargeable ou remplaçable) ; les dispositifs récents sont **compatibles IRM** — signalez-le à toute équipe de radiologie.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- Rougeur, gonflement, écoulement ou fièvre (infection possible)
- Douleur nouvelle ou aggravée au niveau du dispositif
- Une **perte soudaine d'efficacité** ou une stimulation inconfortable

Bon à savoir

- Le dispositif peut être **éteint ou retiré** si nécessaire.
- Parce que vous testez d'abord, la plupart des personnes implantées sont confiantes que ça les aide.

TROIS CHOSES À RETENIR

- 1.** La SNM est un petit « stimulateur » implanté pour la vessie et l'intestin, en cas de vessie hyperactive, rétention ou fuites intestinales résistantes aux autres traitements.
- 2.** Vous **la testez d'abord** pendant 1–2 semaines ; l'implant définitif n'est posé que si l'amélioration est clairement démontrée.
- 3.** Elle est pilotée par télécommande et réversible. Appelez en cas d'infection au site, de douleur nouvelle ou de perte soudaine d'effet.